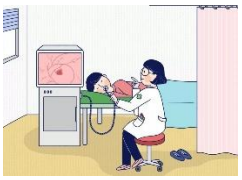
四、检查



1.**血培养（首选和金标准）**：**无**需在体温升高时采血 持续菌血症

2.**超声心动图**如经**食管**超声心动图 **TEE** VS胸超，TEE敏感性和特异性都↑

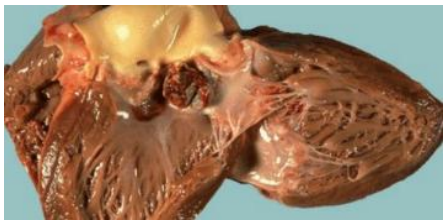
	感染性心内膜炎	SLE 疣状 Libman-Sacks 心内膜炎
赘生物	**含菌**	不含菌
多位于	主动脉瓣心室侧、二尖瓣心房侧、室间隔缺损的右心室侧	二尖瓣心室侧（引狼入室）

主闭返流到心室 二闭返流到心房 室缺返流到右心室

在反流的下游 会描述赘生物所在位置或是否含菌

3.CT

4.免疫学检查：高丙种球蛋白血症（25%）、类风湿因子（50%）、循环免疫复合物（80%）





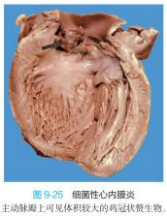


图 9-25 细菌性心内膜炎
主动脉瓣上可见体积较大的赘生物。

五、治疗

1.抗感染 大剂量长疗程 大长经 提高疗效，减少药物的不良反应
↑ ↗保持稳定的血药浓度↗ 适量

①早期、足量、静脉、杀菌、联合 VS结核治疗：早恋全是短命鬼

②**2-6 周**（人工瓣膜心内膜炎 6-8 周） 激素冲击治疗：大剂量，短疗程

③**不用红霉素、氯霉素、磺胺、四环素等抑菌剂**（红绿灯）

④**联合氨基糖苷类抗生素**（大肠杆菌菌血症常见、但它黏附性差）

小凯笔记自行整理

SLE	亚心炎
都常低中热 都常累及肾脏	
	更强调心脏杂音 （基础瓣膜病或先心病）
血液系统受损，WBC往往↓	感染，WBC往往↑
赘生物常位于二尖瓣心室侧	赘生物常位于反流下游

2.外科指征（三大师流脓真衰塞）

感染性心内膜炎并发急性心梗应立即做PCI介入

①**赘生物＞30**mm、或**＞10**mm **伴严重瓣膜**狭窄或反流 血液反流到左心房→左心房压力↑→肺水肿

②瓣叶**穿孔**破裂或瘘所致**心衰/肺水肿/休克**（不是心梗） 瓣叶穿孔已导致急性左心衰→心源性休克

③未能控制的局部感染灶：假性动脉瘤、脓肿、瘘、赘生物增大

④**真菌**或多重耐药菌 无特效药

⑤积极抗生素治疗下出现栓塞、或血培养仍阳性
保守治疗无效

真题解析·感染性心内膜炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2015N139-140 B

A.心瓣膜区杂音 基础疾病

B.脾肿大

C.贫血

D.环形红斑 风湿、结核性风湿症

亚急性感染性心内膜炎一般不出现的临床表现是

急性风湿热一般不出现的临床表现是

不再iPhone